ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL MUNICIPAL

PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

PAI



FAM - BOLIVIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLIVIA

unicef
para cada infancia

Enrique Leaño Palenque
PRESIDENTE

Gabriela Jiménez Vaca
VICEPRESIDENTE

Josefina Velásquez Correa
SECRETARIA GENERAL

Rodrigo Puerta Orellana
DIRECTOR EJECUTIVO

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia - FAM-Bolivia
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia - FAM-Bolivia
Av. 14 de septiembre Nro. 6154 (Obrajes), entre calles 15 y 16
Página Web: fam.org.bo

Contenidos:
Carla Maritza Hidalgo Lara

Diseño y Diagramación de la Guía:
Alejandra Yazmin Sainz Miranda

CONTENIDO

PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO.....4

GLOSARIO.....6

1. ENFOQUE DE ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO.....7

2. ENFOQUE DE LA SALUD UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN DE MORTALIDAD A TRAVÉS DE LA INMUNIZACIÓN.....9

3. MARCO METODOLÓGICO.....11

3.1. ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL MUNICIPAL.....11

3.1.1 Definiciones 11
3.1.2 Estructura de contenido..... 11
3.1.3 Participantes y Responsables 13
3.1.4 Proceso de elaboración del POA y el presupuesto anual.....13

3.2 PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL NIVEL MUNICIPAL.....24

3.2.1 Organización del PAI.....25
3.2.2 Escenario de elaboración del POA y participantes.....25
3.2.3 Balance de ejecución y análisis de entorno.....26
3.2.4 Plan de vacunación.....28
3.2.5 Programación de actividades..... 29

3.3 HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL POA – APLICACIÓN PAI.....31

4. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y COMPETENCIAS PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.....44

5. MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMPETENCIAS.....46

REFERENCIAS ADICIONALES.....48

ANEXOS.....48

PRESENTACIÓN Y PROPÓSITO

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM – Bolivia, en su calidad de institución de derecho privado, sin fines de lucro y dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, formada libre y voluntariamente por once entidades de representación municipal, que constituyen el Sistema Asociativo Municipal boliviano tiene entre sus roles; el de promover y desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades de gestión municipal.

UNICEF por su parte, ha venido acompañando a gobiernos municipales en el fortalecimiento de su rol, a través de iniciativas diversas que han conducido a mejoras significativas en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, la intervención y despliegue en el nivel municipal es desafiante para el trabajo de UNICEF ante la existencia de 336 gobiernos municipales distribuidos en los 9 departamentos del país.

Juntos, UNICEF y la FAM - Bolivia, han establecido un acuerdo interinstitucional basado en sus objetivos comunes y en la capacidad de convocatoria, llegada y coordinación de la FAM - Bolivia, a fin de potenciar los resultados de las acciones conjuntas.

La planificación, en un instrumento fundamental en la gestión de toda institución pública y por lo tanto adquiere trascendencia a nivel municipal, toda vez que éste es el nivel más cercano a la población y su gestión es 100% operativa. Al ser el POA uno de los instrumentos de la planificación de corto plazo más importantes para la asignación de recursos en las entidades públicas, se constituye en uno de los elementos clave de la gestión municipal.

Es por ello necesario, contar con instrumentos de apoyo y desarrollar procesos de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios municipales; con este fin, UNICEF y la FAM - Bolivia han promovido y auspiciado la elaboración de la presente Guía para la Elaboración del POA y el presupuesto municipal anual orientado al sector salud, con énfasis en el Programa Ampliado de Inmunización PAI.

La guía esta dirigida principalmente a funcionarios de la jurisdicción municipal, que forman parte del equipo de salud del PAI; tiene el propósito de brindar conocimiento metodológico de la planificación del desarrollo en Bolivia enfatizando la planificación de corto plazo y la relevancia que tiene el PAI como componente operativo en la gestión de los Gobiernos Autónomos Municipales GAMs, para alcanzar los objetivos de largo plazo en salud, establecidos por el gobierno.

La Guía está estructurada en seis (6) acápites, comenzando por mostrar el marco referencial de la articulación en la planificación y la estructuración e importancia del Programa Ampliado de Inmunización.

El acápite que desarrolla la metodología de planificación de corto plazo, tiene la intención de que el lector tenga en mente el esquema de formulación del POA y presupuesto anual municipal al momento de relacionarlo con el PAI.

El acápite destinado a la planificación de corto plazo del PAI sigue la línea metodológica de formulación del POA apoyándose en la organización, mecanismos administrativos y herramientas propias del programa, que coadyuvan a la obtención estructurada de información útil y necesaria para una buena programación de actividades.

A fin de no interrumpir la narrativa metodológica con la introducción de las herramientas de planificación, se ha desarrollado por separado el acápite que contiene específicamente los formularios de apoyo a la elaboración del POA y presupuesto anual, presentados en el orden secuencial de su aplicación; acápite que encuentra complementación en los anexos, con algunos instrumentos de apoyo a la planificación pertenecientes a instancias rectoras del sector salud, planificación y de presupuestos.

Se ha optado por ubicar el acápite del marco normativo en la última parte de la Guía, tanto de la planificación del desarrollo, como del PAI, a fin de concentrar la atención del lector en el componente técnico de elaboración del POA y presupuesto, de modo que sea evidente la esencia metodológica de la misma. Por otro lado, a fin de procurar la coherencia en su redacción y para que ésta facilite la lectura y entendimiento del contenido; se ha incluido un glosario de siglas.

GLOSARIO

ETA	Entidad Territorial Autónoma
GAM	Gobierno Autónomo Municipal
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
MEFP	Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
MPD	Ministerio de Planificación del Desarrollo
PAI	Programa Ampliado de Inmunización
PDES	Plan de Desarrollo Económico y Social
PEI	Plan Estratégico Institucional
PGDES	Plan General de Desarrollo Económico y Social
POA	Plan Operativo Anual
PTDI	Plan Territorial de Desarrollo Integral
PSDI	Plan Sectorial de Desarrollo Integral
SAFCI	Salud Familiar Comunitaria Intercultural
SEDES	Servicio Departamental de Salud
SPIE	Sistema de Planificación Integral del Estado
SP	Sistema de Presupuestos
SPO	Sistema de Programación de Operaciones
SUS	Sistema Único de Salud

1 ENFOQUE DE ARTICULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

La planificación del desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien, se rige desde el 21 de enero de 2016, por lo establecido en la Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE que, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación del Desarrollo, tiene como fin: "lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tengan un enfoque integrado y armónico; y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales" además de "orientar la asignación óptima de los recursos financieros y no financieros del estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación".

El esquema de planificación del desarrollo definido en el SPIE, establece que las entidades públicas en todos sus niveles, para asignar recursos deben elaborar, ejecutar y evaluar sus planes, políticas y programas, de acuerdo a las normas que emanen del Órgano Rector y en el marco del Plan General del Desarrollo Social PGDES, actualmente reflejado en la Agenda Patriótica 2025 "Para Vivir Bien".



ILUSTRACIÓN No. 1 ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

En la ilustración No. 1 vemos que únicamente el nivel central tiene la atribución de formular la planificación de largo plazo PGDES y la de mediano plazo PDES; sin embargo, todas las demás instituciones de todos los niveles del gobierno, deben contar con planes de mediano y corto plazo institucionales compatibles entre sí, preservando la unidad entre los objetivos y políticas nacionales, departamentales y municipales.

Los Ministerios sectoriales están a cargo de la formulación de los Planes Sectoriales PSDI.

Los planes departamentales por su parte, deben recoger la visión, los objetivos y políticas de mediano plazo del país definidos en el PDES; y deben sistematizar la oferta estatal departamental de una manera territorializada para orientar la elaboración de los

planes de desarrollo municipal de mediano y corto plazo. El trabajo de formulación de estos planes debe ser participativo, involucrando a las entidades públicas sectoriales, sector privado y actores sociales de cada jurisdicción a fin de lograr concertación.



ILUSTRACIÓN No. 2 ARTICULACIÓN PARTICIPATIVA A NIVEL TERRITORIAL

En esta lógica de articulación, el PDES define el conjunto de objetivos y políticas integrales (eje estratégico) de carácter nacional, traducidos en metas, resultados y acciones; a partir de los pilares del PGDES, y define al mismo tiempo los planes de mediano y corto plazo en cada nivel de gobierno; la estructura programática del PDES nos guía en esta secuencia de relación:

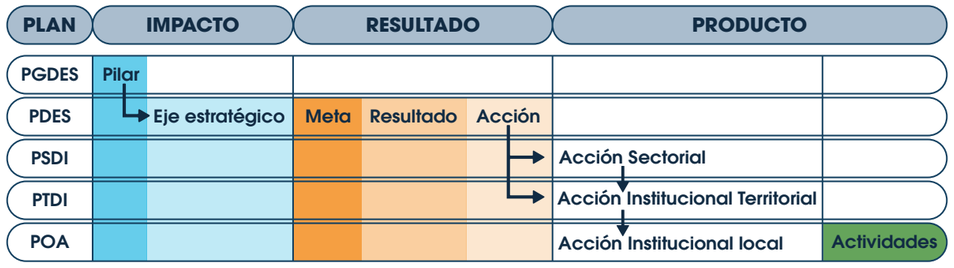


ILUSTRACIÓN No. 3 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES

Así como la planificación en términos de programas, acciones y proyectos debe estar articulada y supeditada al PDES, la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se supedita al Presupuesto General del Estado; que engloba el total de recursos del gobierno en todos sus niveles e instituciones.

Cada plan de mediano y corto plazo está relacionado a un presupuesto de la misma temporalidad; cuya formulación debe basarse en el principio de equilibrio fiscal; es decir que no se puede gastar más de lo que se tiene.

El SPIE procura el éxito del proceso de planificación, con su última finalidad, que es "Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública", incorporando en el proceso a la sociedad a través del CONTROL SOCIAL, tanto del componente operativo como de ejecución presupuestaria y, garantizando con esto el cumplimiento de lo formulado en cada uno de los planes y sobre todo el logro de la meta País.

2 ENFOQUE DE LA SALUD UNIVERSAL Y LA PREVENCIÓN DE MORTALIDAD A TRAVÉS DE LA INMUNIZACIÓN

La Agenda Patriótica 2025 (PGDES) en su pilar No. 3 "Salud, Educación y Deporte para la formación de un ser humano integral" incluye dentro de sus metas, la reducción de la mortalidad y la implementación del Servicio de Salud Universal SUS; éste último, como mecanismo para garantizar lo anterior.

Asimismo, el SUS responde a la meta No. 3 correspondiente al Eje estratégico No. 6 del PDES 2021-2025 "Salud y Deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia"; y al segundo lineamiento estratégico de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI del Plan Sectorial de Salud 2021-2025; orientados a garantizar el acceso universal, gratuito y de calidad a toda la población al Sistema Único de Salud Familiar, Comunitaria Intercultural.

El Estado asegura la asignación de recursos al sector salud a nivel local a través de la Ley No. 1152, estableciendo que los GAM financiarán la atención a su población en el Primer y Segundo Nivel de Atención con los recursos provenientes del quince punto cinco por ciento (15.5%) de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente del IDH y que a fin de garantizar el acceso a la salud de su población, destinarán un porcentaje mayor al 15.5% señalado u otros recursos adicionales, cuando el mismo sea insuficiente.

Los GAM deberán priorizar la provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos, insumos y reactivos necesarios para garantizar la continuidad de la atención a las beneficiarias y los beneficiarios.

Cumplido lo anterior y en caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en la "Cuenta de Salud Universal y Gratuita", serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades:

a. Fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud.
b. Programas especiales de salud.
c. Contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud.

El presupuesto para establecimientos de salud de Primer Nivel de Atención, se realizará con base a criterios poblacionales, de accesibilidad y cobertura de servicios promocionales y preventivos y en la programación de servicios curativos, según reglamentación específica del Ministerio de Salud.

Bajo este escenario, en junio de 2008, en Bolivia se estableció el Modelo de Atención y Gestión de la Salud en el marco de la política nacional SAFCI a través del Decreto Supremo No. 29601. Bajo la consiga de que "La Salud es un Derecho para Vivir Bien", la política SAFCI plantea el fortalecimiento normativo del Programa Ampliado de Inmunización Familiar y Comunitaria PAI, con el fin de "Reducir el riego de enfermar y morir por enfermedades inmunoprevenibles, mediante la aplicación universal

de vacunas y una vigilancia epidemiológica oportuna y eficiente, desarrollada por personal de salud capacitado para tal fin" y en los tres niveles de atención.

El PAI es el programa nacional de prevención, vigilancia y control de las enfermedades prevenibles por vacunas, con una visión, misión, objetivos y metas claramente definidas y vinculadas al pilar 3 – eje estratégico No. 6 del PDES 2021-2025.

Oficialmente, en Bolivia el PAI fue organizado en octubre de 1979; a partir de entonces se ha constituido en el programa preventivo más importante de las políticas de salud y en su ejecución ha ido desarrollando diversas estrategias con el fin de cubrir al 100% de la población objetivo, vale decir niñas y niños menores de cinco años, sin que por ello se descuide a la población adulta; tal como se observa en el Esquema Nacional de Vacunación:

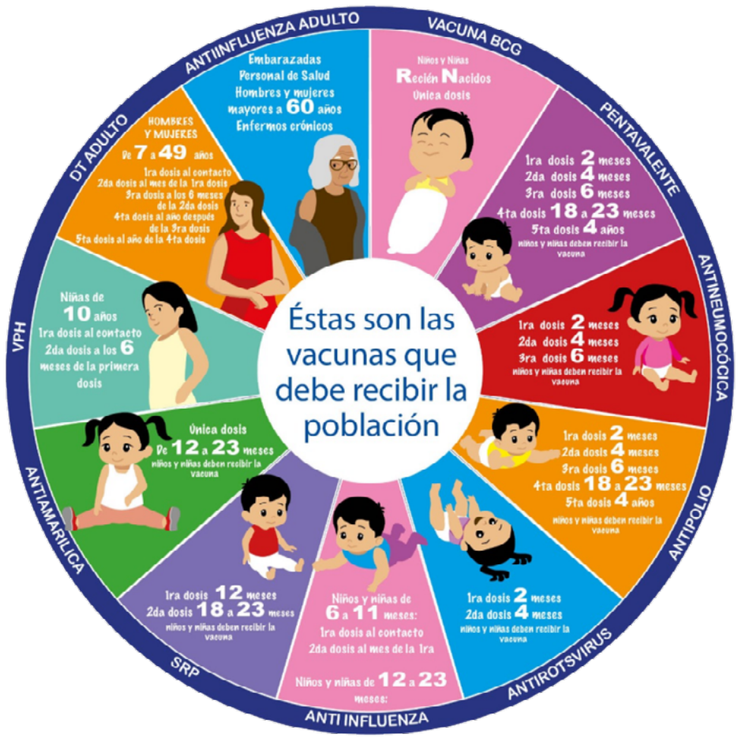


ILUSTRACIÓN No. 4 ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

La importancia de impulsar y fortalecer el PAI, surge de la situación epidemiológica del país, que muestra a las enfermedades inmunoprevenibles como la 3ra causa de mortalidad infantil en Bolivia después de las EDAs e IRAs.

Con toda la estructura mencionada, el Estado Plurinacional garantiza a los niños y niñas de Bolivia el derecho a la vacunación gratuita, sin ningún tipo de discriminación, en concordancia con lo establecido en la Agenda Patriótica.

3 MARCO METODOLÓGICO

3.1. ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL MUNICIPAL

3.1.1 Definiciones

El **POA** es un instrumento de gestión operativa proyectada a un año, que de manera sistemática permite:

a. Identificar objetivos y metas institucionales.
b. Identificar y definir las operaciones necesarias para lograr los objetivos y metas.
c. Determinar y estimar los recursos necesarios para ejecutar las operaciones y los tiempos de ejecución.
d. Designar responsables de las operaciones.
e. Definir y establecer los indicadores para el control de cumplimiento.

El cumplimiento sucesivo de los POAs permite lograr los objetivos definidos a mediano plazo.

El **presupuesto anual**, al ser un plan económico y financiero vinculado al POA, se convierte en una herramienta fundamental de gestión. Contiene las previsiones de ingresos que se espera obtener en un año y las asignaciones de gasto para el mismo periodo, donde lo primero debe ser igual a lo segundo.

3.1.2 Estructura de contenido:

El documento del POA y presupuesto institucional mínimamente debe tener el siguiente contenido:

- ✓ Marco legal.
- ✓ Marco institucional y estratégico.
- ✓ Análisis de entorno y situación.
- ✓ Objetivos, Metas e Indicadores de seguimiento y medición de los resultados.
- ✓ Acciones de corto plazo y operaciones.
- ✓ Programación de operaciones (Programas y proyectos, actividades, tiempos de inicio y finalización y responsables).
- ✓ Identificación y estimación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones y operaciones; cuantificación y asignación de presupuesto.

Para una mejor comprensión, se definen los siguientes términos:

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Programa	Conjunto de directrices o acciones diseñadas y organizadas con un propósito específico y para alcanzar metas y resultados específicos. De acuerdo a la estructura programática del PDES, un programa de mediano plazo debe estar articulado a una acción de mediano plazo.
Acción	De acuerdo a la definición de las Directrices de Formulación Presupuestaria, las acciones de corto plazo se constituyen en el fundamento y dirección de las operaciones institucionales a desarrollar al interior de cada una de ellas a lo largo de una gestión fiscal; sus resultados son medibles, cuantificables y verificables a través de indicadores. Una o más acciones de corto plazo (según sea necesario) deben estar articuladas a un programa de mediano plazo; y éste a su vez debe estar articulado a una acción de mediano plazo. Un programa de mediano plazo puede contener más de una acción de corto plazo.
Operación	Conjunto de tareas o actividades específicas interrelacionadas, cuya ejecución está dirigida a contribuir en la producción de bienes y prestación de servicios, a fin de lograr determinadas acciones y resultados. Las operaciones se clasifican en: • De funcionamiento (recurrentes): Son aquellas que producen bienes y servicios que permiten a la entidad cumplir su misión • De inversión (no recurrentes): Se refiere a aquellas relacionadas a la inversión pública capitalizable o no capitalizable1.
Actividad	Pueden entenderse como pasos lógicos que permiten la ejecución de las operaciones. El resultado final de una actividad puede ser total o parcial respecto al resultado final de la operación que integra. Las actividades que integran las operaciones deben distinguirse de manera exclusiva, permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad.
SS Indicador	Según las Directrices de Formulación Presupuestaria, un indicador es la relación de una o más variables, utilizadas para observar o medir en un momento determinado, cualitativa o cuantitativamente las acciones y resultados obtenidos efectivamente. Las unidades de medida, pueden adoptar distintas formas, que van de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, de lo absoluto a lo relativo. La formulación de un indicador debe considerar lo siguiente: • Descripción breve del indicador • Unidad de medida • Fórmula de cálculo • Línea de base • Meta estimada que se desea alcanzar Un indicador se relaciona directamente a la acción cuyos resultados de su ejecución se pretende medir. Una acción puede tener más de un indicador.

3.1.3 Participantes y Responsables

La responsabilidad de la elaboración del POA y el presupuesto anual recae sobre la Máxima Autoridad Ejecutiva del GAM, es decir la Alcaldesa o Alcalde; quien debe realizar las convocatorias, presidir las reuniones y talleres de mayor importancia, designar al equipo técnico, dar conformidad a la propuesta final y remitirla al Concejo Municipal para su aprobación.

La normativa establece que el proceso de planificación es participativo, por lo que en la elaboración del POA se debe involucrar a todos los actores públicos, sociales y privados de la jurisdicción del GAM:

- ✓ El GAM: conformado por el Ejecutivo Municipal (alcalde, equipo técnico y funcionarios municipales), y el Concejo Municipal.
- ✓ Organizaciones sociales: entre las que se encuentran Organizaciones Territoriales de Base, Asociaciones comunitarias, Organizaciones funcionales (financieras, productivas, sociales, culturales, entre otras).
- ✓ Otras instituciones: como la Iglesia, ONGs, Fundaciones, Empresas privadas, etc. Dentro de la jurisdicción del GAM.

El Concejo Municipal, debe acompañar el proceso de elaboración del POA sobre todo en las primeras etapas; y tiene la responsabilidad de aprobar el POA y presupuesto municipal dentro de los plazos fijados y garantizando el cumplimiento de las normas relacionadas.

Las organizaciones sociales por su parte tienen la atribución de plantear sus demandas y proponer proyectos en beneficio de sus comunidades o barrios; revisar la propuesta del POA y de ser necesario proponer modificaciones en cuanto a prioridades y/o plazos de ejecución.

3.1.4 Proceso de elaboración del POA y el presupuesto anual

3.1.4.1 Consideraciones para la elaboración del POA y presupuesto

En la elaboración del POA y el presupuesto anual, debe considerarse en todo momento:

- ✓ Las competencias asignadas.
- ✓ Que las acciones de corto plazo estén articuladas con las acciones de mediano plazo.
- ✓ La disponibilidad financiera de recursos, sobre la base de los techos presupuestarios socializados por el MEFP y en el marco de la normativa vigente; además de la integración del presupuesto anual al presupuesto plurianual correspondiente; considerando las mismas asignaciones programáticas y fuentes de financiamiento de ésta última.

3.1.4.2 Sistemas y sub sistemas para la formulación del POA y presupuesto

La norma nacional establece los sistemas de Planificación Operativa SPO y de presupuestos SP y sus correspondientes subsistemas, que dan lineamientos metodológicos para la formulación del POA y presupuesto de manera complementaria para una planificación dinámica, articulada y participativa. Estos son:

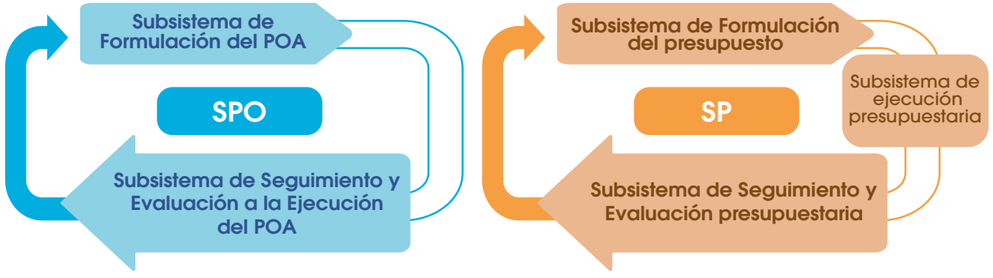


ILUSTRACIÓN No. 5 SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO

La implantación y aplicación de estos subsistemas en forma de circuito, durante el proceso de elaboración del POA y presupuesto, permite optimizar el resultado de la planificación y la gestión institucional subsecuente.

3.1.4.3 Proceso de elaboración del POA y presupuesto anual

El proceso de elaboración del POA y presupuesto para el siguiente año, inicia en la etapa de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA y presupuesto del año en curso, a partir de lo cual se puede identificar las acciones de corto plazo susceptibles de incluir en el POA que se va a elaborar.

La ruta de elaboración del POA y presupuesto anual consta de varios pasos o actividades, que con fines didácticos pueden resumirse en las siguientes etapas críticas:



ILUSTRACIÓN No. 6 RUTA DE ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL

1 PREPARACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

A fin de tener una correcta organización y preparación del trabajo de elaboración del POA y presupuesto, se debe tener presente el plazo oficial para la presentación del documento final debidamente aprobado por instancia competente ante el órgano rector.

A. CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN

Si bien la ruta de elaboración del POA y presupuesto anual para la siguiente gestión, inicia con una etapa de evaluación de la situación en curso que usualmente coincide con el mes de junio de cada año, el cronograma oficial inicia con la emisión y socialización por parte del órgano rector, de:

- Circular Instructivo para la formulación del POA y presupuesto anual: Establece los plazos para la elaboración del POA y su presupuesto, y el plazo para su remisión al órgano rector.

- Comunicación de techos presupuestarios y directrices de formulación.

Habitualmente y de manera referencial, los cronogramas de trabajo coinciden con los siguientes tiempos; donde la marca X señala probabilidad de ocurrencia:

ETAPAS	ACCIÓN	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.
1 y 2	Análisis del entorno, seguimiento a la ejecución del POA y presupuesto vigentes y Balance de Ejecución.	X			
3 a 5	Formulación del POA y presupuesto anual		X	X	
6	Aprobación legislativa y remisión al Órgano Rector			X	

B. DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

Para la realización de las tareas, primeramente, la MAE (Alcaldesa o Alcalde) debe conformar y designar el equipo técnico que para la elaboración del POA.

Para ello debe convocar a la primera reunión oficial, a todos los actores de la jurisdicción del GAM, involucrados en la elaboración del POA y de manera conjunta deben elaborar un plan de trabajo, de acuerdo al siguiente formato referencial:

PLAN DE TRABAJO
ELABORACIÓN POA Y PRESUPUESTO 2024

Municipio:
Departamento:

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	LUGAR	RESPONSABLE	PARTICIPANTE
Balance de ejecución gestión anterior				
Elaboración de la propuesta institucional				
Consulta y consenso social				
Elaboración proyecto de POA y presupuesto				
Aprobación en el Concejo Municipal				

Responsable de seguimiento: .....
Lugar y fecha: .....
FIRMAS DE CONFORMIDAD - PARTICIPANTES:

Es importante contar con un acta formal de la reunión celebrada, en la cual además quedan expresos los compromisos asumidos para el cumplimiento en tiempo y forma de la elaboración del POA municipal, además de los nombres de los representantes elegidos para conformar el equipo técnico de trabajo, que serán nombrados por la MAE.

INTEGRAN EL EQUIPO TÉCNICO:

La MAE, miembros del Concejo Municipal y del Comité de Vigilancia; además de representantes de cada una de las Secretarías municipales, de sectores sociales y de la sociedad organizada.

Los representantes que participaron en esta primera reunión, tienen la obligación de socializar el plan de trabajo: en el caso de representantes de las Secretarías del GAM, a sus dependientes; en el caso de organizaciones sociales, al interior de sus instituciones civiles; e involucrarlos en el desarrollo de las actividades planificadas al interior de sus propias organizaciones.

En adelante, durante la ejecución del plan de trabajo, es importante contar con respaldos documentarios de los resultados obtenidos en cada etapa, y la conformidad de los participantes; en forma de actas y/o fichas técnicas.

2 BALANCE DE EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN ANTERIOR

Esta etapa se desarrolla en dos fases que bien podrían llevarse a cabo de manera paralela:

A. REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DEL POA DE LA GESTIÓN ANTERIOR.

Corresponde a trabajo de oficina a cargo del equipo técnico designado; y para su desarrollo se requiere contar mínimamente con los siguientes instrumentos:

- POA municipal de la gestión en curso.
- Informes de avance y seguimiento de operaciones y/o proyectos.
- Herramienta de seguimiento operativo y presupuestario. *(Véase acápite de herramientas)*

En sujeción al plan de trabajo definido y de acuerdo a lo establecido en los Subsistemas de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y del presupuesto, el equipo técnico, inicialmente revisa la ejecución del POA en curso con el fin de identificar principalmente:

- ✓ Acciones concluidas, o que serán concluidas en la gestión en curso.
- ✓ Acciones que en la gestión en curso quedarán inconclusas y el porcentaje no ejecutado deberá pasar a la siguiente gestión.
- ✓ Acciones que justificadamente no se ejecutarán y tampoco serán trasladadas a la siguiente gestión. Por ejemplo, aquellas que no estén alineadas al PTDI y PEI.
- ✓ Acciones cuya programación de ejecución se extiende hacia la siguiente gestión.

Del mismo modo se procede con el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, que consiste en la elaboración de los reportes de ejecución por categoría programática y en relación a la ejecución física prevista en el POA, tanto del presupuesto de recursos como de gastos, vinculando con el cumplimiento gradual y total de los objetivos de gestión previstos.

B. ANÁLISIS DE ENTORNO E IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

Para llevar a cabo esta tarea satisfactoriamente, se precisa contar con el Plan de Mediano Plazo del GAM y los POA que lo integran (de años anteriores).

En primera instancia el equipo técnico debe identificar aquellos proyectos programados para cinco años cuya ejecución total o parcial están pendientes.

Adicionalmente y sin perder de vista las acciones plasmadas en el PTDI y el presupuesto plurianual, los GAM realizan un análisis de la situación actual del entorno interno y externo de su jurisdicción, a fin de identificar factores internos que fortalecen o debilitan la gestión municipal y el logro de los objetivos; así como factores externos que puedan representar oportunidades a aprovechar o amenazas que se deba sortear; identificando también acciones de demanda nueva debidamente alineadas al plan de mediano plazo.

El resultado de esta etapa de trabajo, es:

- ✓ Listado de acciones de corto plazo susceptibles de ejecutarse en la siguiente gestión; resultado del balance de ejecución del POA en curso.
- ✓ Listado de proyectos pendientes de ejecución.
- ✓ Nuevas demandas de proyectos, acordes al PTDI.
- ✓ Saldos presupuestarios estimados.
- ✓ Análisis conclusivo de situaciones favorables o desfavorables para el municipio y recomendaciones consecuentes.

HASTA AQUÍ, LOS GAM HAN IDENTIFICADO ACCIONES DE CORTO PLAZO SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR EN EL POA DE LA SIGUIENTE GESTIÓN Y, TIENEN UN PANORAMA TENTATIVO DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA.



En caso de que el municipio no cuente con PTDI ni PEI, se procede a identificar y priorizar acciones de corto plazo que se encuentren alineadas con el PTDI departamental y el PDES

3 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA INSTITUCIONAL

La elaboración del POA y el presupuesto anual, se rige a lo establecido en los subsistemas de Formulación; la siguiente ilustración nos muestra los elementos o tareas que los integran:

A. ELEMENTOS DE LA FORMULACIÓN

SPO
Subsistema de Formulación del POA

Programación de Acciones de Corto Plazo

Se debe identificar las acciones que serán incluidas en el POA, y establecer tiempos de inicio y finalización para su ejecución.

Esto permitirá la identificación de operaciones subsecuentes

Determinación de Operaciones

Para cada acción programada, identificar las operaciones y tareas específicas a desarrollar, sujetas a seguimiento, cuantificación y verificabilidad; clasificándolas en categorías de funcionamiento y de inversión pública.

Determinación de Requerimientos

Para cada acción programada, debe determinarse los requerimientos de personal, insumos, materiales, activos, servicios y otros necesarios; así como definir un cronograma de plazos para su dotación.

SP
Subsistema de Formulación del presupuesto anual

Estimación de recursos

Se debe estimar la disponibilidad de recursos para la gestión, observando las restricciones establecidas. Estos recursos corresponden a:

- Límites financieros (techos presupuestarios) establecidos por el MEFP para recursos del TGN.
- Recursos propios generados por el ejercicio de competencias.
- Recursos de fuentes diferentes al TGN, para proyectos y programas.

Definición de la Estructura programática

Se debe definir la estructura programática del presupuesto, estableciendo los planes y programas en base al POA, y en el ámbito de sus competencias; identificando los objetivos de gestión, resultados esperados, indicadores de desempeño y asignación de recursos a cada categoría programática; además de los bienes y servicios que genera según sus competencias.

Programación del presupuesto de gastos

Se debe programar el gasto contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal inherentes al desarrollo de las actividades previstas en el POA.

El POA se articula al Presupuesto anual, vinculando una a una las acciones de corto plazo con los programas correspondientes de la estructura programática del presupuesto (Art. 17 NB.SPO)

B. FASES DE LA FORMULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO

El desarrollo de los elementos que componen la formulación de POA y presupuesto deben realizarse en diferentes momentos:

MOMENTO 1 - FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA OPERATIVA



Socializados al interior del GAM los techos presupuestarios y la instrucción para elaborar el POA; y en base a los resultados de la etapa anterior; el equipo técnico, debe:

Establecer acciones de corto plazo que se proponen alcanzar en la siguiente gestión, vinculadas al PTDI y la estructura programática del PDES de cada área, sector y programa según corresponda.

a. Clasificar las acciones como de inversión o de funcionamiento.

b. Puntualizar las operaciones necesarias para cada acción.

c. Designar responsables de las operaciones.

d. Definir tiempos de ejecución por acción y operación.

e. Establecer indicadores para la medición de resultados.

f. Estimar requerimiento de recursos para la ejecución de las acciones y operaciones.

g. El equipo del área de planificación deberá consolidar la información en la matriz correspondiente. *(Véase acápite de herramientas)*

MOMENTO 2 - FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO



El equipo de la Unidad de Presupuestos debe:

a. Estimar el presupuesto de recursos; lo que implica determinar e incluso gestionar potenciales fuentes de financiamiento y estimar los recursos con los que se va a contar para ejecutar el POA que se está elaborando. *(Se debe utilizar los clasificadores del MEFP – Véase acápite de herramientas)*

b. Definir la estructura programática: Aplicando las Directrices Presupuestarias del MEFP y la codificación definida en dicho documento, procede a vincular las acciones institucionales de corto plazo con la estructura programática del presupuesto (agrupando como Programas, Proyectos y actividades, y asignando el código correspondiente) que tiene una relación directa con los programas definidos en el PDES.

c. De entre las acciones programadas para la siguiente gestión, identifica y diferencia las mismas según sean de GASTO CORRIENTE o de GASTO DE INVERSIÓN, para una correcta asignación presupuestaria.

d. Determina el presupuesto de gastos: Asigna recursos para la ejecución de las acciones y operaciones definidas, tomando como referencia el presupuesto plurianual, los techos presupuestarios y relacionando con la fuente de financiamiento y el organismo financiador. (*Véase acápite de herramientas)*

En todo momento se debe garantizar el cumplimiento del principio de equilibrio fiscal.

MOMENTO 3 - FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA INSTITUCIONAL



El equipo técnico de la Unidad de Planificación, consolida toda la información proporcionada en las herramientas correspondientes (véase acápite de herramientas), tanto de la propuesta operativa como la de formulación presupuestaria y elabora el documento de la propuesta institucional del POA municipal articulando el componente operativo con el presupuestario.

El resultado de este trabajo es el documento de la propuesta institucional.

4 CONSULTA Y CONSENSO SOCIAL

La propuesta institucional es socializada a todos los actores de la jurisdicción, en evento municipal convocado por la MAE, para su discusión y consenso.

Las consignas fundamentales para la discusión y logro de consensos deben ser:

- ✓ Los fondos municipales son limitados.
- ✓ La priorización de acciones y proyectos es según grado de interés de la mayoría y por distritos.
- ✓ La priorización también responde a la existencia de compromisos y acuerdos interinstitucionales iniciales que garanticen la disponibilidad de recursos para proyectos.

En esta oportunidad, y de acuerdo a la metodología preparada por los técnicos del GAM, los actores sociales pueden realizar observaciones u aportes a la propuesta institucional, pudiendo plantear reprogramaciones en las acciones y operaciones programadas; no así respecto al presupuesto.

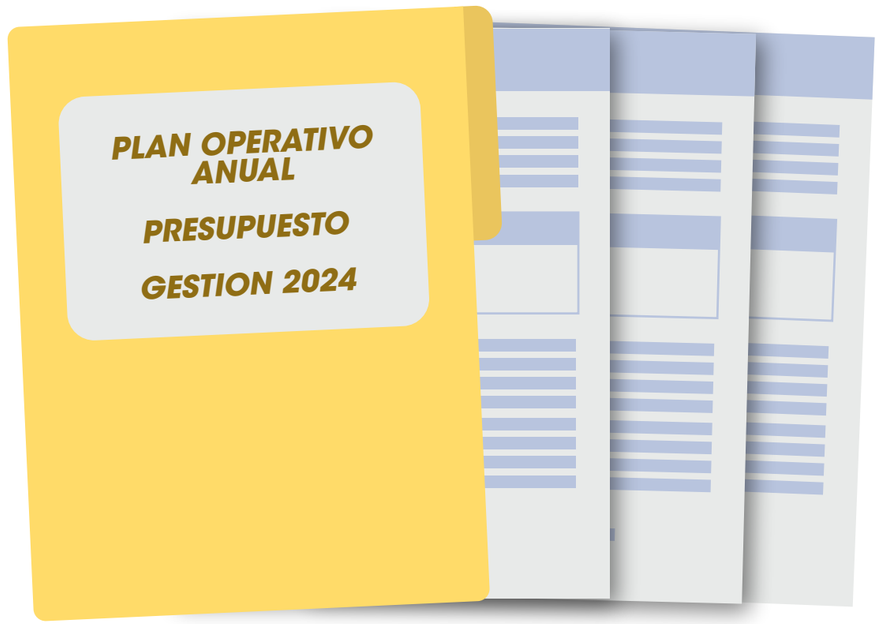
El resultado de este trabajo debe plasmarse en un acta de reunión oficial, que registre los resultados y conclusiones, los acuerdos y compromisos alcanzados, recomendaciones y toda modificación consensuada a la propuesta institucional; reflejando la conformidad de los asistentes. Este material debe ser utilizado en la elaboración del documento final del POA municipal.

5 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL POA Y PRESUPUESTO

Contando con la programación de operaciones y el presupuesto consolidados; debidamente agrupados y a conformidad de los actores sociales de la jurisdicción; garantizada la articulación al PTDI y la sujeción a la normativa correspondiente; el equipo de trabajo de la Unidad de Planificación, de manera coordinada elaboran el documento formal del POA que incluye el presupuesto municipal.

El documento debe ser elaborado considerando la estructura de contenido mínimo incorporando las herramientas/formularios utilizados a lo largo del proceso.

Este documento será elevado a la MAE para su conformidad; ésta es la que remitirá el POA al órgano legislativo del GAM para su aprobación y posterior envío al órgano rector.



6 APROBACIÓN EN EL CONCEJO MUNICIPAL Y REMISIÓN AL ORGANO RECTOR

De acuerdo a normas internas del Concejo Municipal, en sesión convocada específicamente para tratar el proyecto de POA y presupuesto institucional para la siguiente gestión, haciendo uso de sus atribuciones y competencias, revisan el contenido del documento, debiendo responder al nivel ejecutivo de acuerdo a los plazos previamente definidos y comunicando las observaciones para inmediata solución o en su defecto su aprobación y elevación a ley municipal; para su inmediata remisión al órgano rector.

En caso de no dar respuesta en el plazo estipulado, de acuerdo a la Ley de Municipalidades, el proyecto de POA y presupuesto institucional anual, queda aprobado automáticamente.

El documento aprobado debe ser enviado por la alcaldesa o alcalde, al MEFP y al MPD en cumplimiento al plazo estipulado, adicionando la norma de aprobación institucional, el pronunciamiento de la instancia de participación y control social, respaldos de los acuerdos y compromisos alcanzados; además de los respaldos de la programación presupuestaria; en formato físico o digital (con firma digital).

3.2 PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA EN EL NIVEL MUNICIPAL

Al introducirnos en la metodología de elaboración del POA y presupuesto municipal, tenemos definido el camino para formular el POA y presupuesto del Programa Ampliado de Inmunización PAI; puesto que la misma metodología debe ser aplicada en el entorno de salud del municipio haciendo uso de la estructura técnica que ha sido diseñada para su funcionamiento a nivel municipal.

El resultado obtenido, será elevado a las reuniones del equipo técnico de elaboración del POA municipal y será la base para alcanzar el consenso social en términos del programa de inmunizaciones.



3.2.1 Organización del PAI

A nivel departamental, la máxima autoridad de Salud es el SEDES con dependencia técnica del Ministerio de Salud y dependencia administrativa de la Gobernación. El PAI hace parte de la estructura técnica y operativa del SEDES y cuenta con la designación de un responsable del Programa y Coordinadores de Redes de Servicios de Salud.

Localmente, el PAI se organiza en redes municipales de servicios de salud, y a nivel de establecimientos de salud. Estos tienen dependencia técnica del SEDES y administrativa con los GAM, específicamente con la Secretaría Sectorial. En cada establecimiento de salud se designa un responsable del PAI y éste es el encargado de organizar las actividades propias del programa, además de gestionar los recursos necesarios con el municipio.

3.2.2 Escenario de elaboración del POA y participantes

Periódicamente y en cada nivel de gestión, se llevan a cabo reuniones del Comité de Análisis de la Información (CAI) con el objetivo de intercambiar, analizar información y evaluar la situación en salud y el funcionamiento de los establecimientos de salud; también, que se cumpla con lo planificado y que el manejo administrativo sea el correcto, entre otros temas.

Entre los objetivos específicos de este Comité están:

- ✓ Identificar necesidades y problemas de salud.
- ✓ Proponer acciones o definir estrategias, plan estratégico o un plan de acciones a corto o mediano plazo, haciendo la toma de decisiones de manera participativa.
- ✓ Establecer niveles de responsabilidad para su posterior seguimiento.

.

A nivel municipal, el Coordinador de la red correspondiente es el que se encarga de las convocatorias, y participan:

- Alcaldesa o Alcalde.
- Equipo técnico de salud del Municipio.
- Personal de salud de los establecimientos.
- Representantes comunitarios y del Comité de Vigilancia.
- Líderes vecinales.
- Médicos tradicionales y parteras entre otros.

Por lo tanto, este es el escenario para elaborar el POA del Programa a nivel municipal.

3.2.3 Balance de ejecución y Análisis de entorno

La planificación de corto plazo del PAI debe tener un enfoque por resultados; por ello todas las actividades deben apuntar a cumplir metas de cobertura, en el marco de lo establecido desde el nivel central de gobierno.

Por lo tanto, el primer paso en la planificación de corto plazo del PAI es la definición a nivel de establecimientos de salud y de red municipal de:

- Objetivos cuantitativos y cualitativos de corto plazo en términos de vacunación.
- Prioridades y Metas.
- Estrategias y tácticas de vacunación.

Para ello, en coherencia con la metodología de formulación del POA es importante realizar un balance del cumplimiento en cuanto a las metas establecidas para la gestión que concluye, y los elementos que incidieron positiva o negativamente en ello.
Los instrumentos iniciales para este trabajo son:

- ✓ Reportes de seguimiento y supervisión del PAI; cuya base son los Formularios de Supervisión PAI – Nivel local de la Serie de Documentos Técnicos Normativos del Ministerio de Salud y Deportes. *(Véase anexo)*
- ✓ Reportes de ejecución presupuestaria de salud por tipo de gasto.
- ✓ Información sobre saldos de caja y bancos, de gasto corriente.
- ✓ Formulario de Seguimiento a la ejecución operativa y financiera . *(Véase acápite de herramientas)*

En caso de existir saldos anuales acumulados en la "Cuenta de Salud Universal y Gratuita", éstos serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades:

a. Fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud.

b. Programas especiales de salud.

c. Contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud.

Por otro lado, para realizar el análisis de entorno se precisa conocer y tener en cuenta los siguientes elementos:

NO.	ELEMENTO	JUSTIFICACIÓN
1	Características de la comunidad	Permite dimensionar la necesidad de vacunas, la capacidad de cobertura y la aceptación de la población, con datos como: ✓ Datos demográficos ✓ Cantidad de establecimientos de salud; coberturas de cada establecimiento, distancias y tiempo de recorrido. ✓ Características culturales y religiosas de la población
2	Inventario de recursos disponibles	Conocer los recursos disponibles, permite conocer las fortalezas y debilidades de la red de salud. Los recursos críticos son: • Establecimientos de salud por número de población. • Personal de salud • Equipos de cadena de frio de acuerdo a las normas técnicas del sector. • Medios y condiciones de transporte para acceder a los establecimientos de salud • Otros necesarios
3	Objetivos cuantitativos y cualitativos de mediano plazo	Los objetivos de vacunación a nivel municipal deben formularse desde el nivel de coordinación con la red de servicios de salud. Esto significa que los objetivos municipales, se definen en base al tamaño de la población objetivo por número de comunidades.
4	Prioridades y metas de mediano plazo	En el marco de las políticas sectoriales y metas de gestión establecidas en los niveles superiores, los grupos de población prioritarios en orden son: niños y niñas menores de cinco años; mujeres y hombres de 7 a 49 años y adultos mayores.

Teniendo presentes estos elementos, sobre todo del inventario de recursos, se cuenta con insumos para analizar y evaluar la situación del PAI a nivel municipal:

RECURSO	FORTALEZAS	DEBILIDADES	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Establecimientos de salud			
Personal de salud			
Cadena de frio			
Medios de transporte para llegar a los establecimientos y abastecer vacunas y otros.			
Otro			

Con toda la revisión y análisis realizado, se facilita la tarea de definir objetivos, prioridades, metas y estrategias de vacunación para la siguiente gestión, aceptadas y apoyadas por la comunidad.

3.2.4 Plan de vacunación

Siguiendo el enfoque de planificación por resultados y contando con la información sistematizada del balance de ejecución de la gestión anterior y el análisis de situación del PAI en el municipio; se debe elaborar el Plan de Vacunación con la definición de los objetivos y metas de vacunación; a partir de lo que se programarán actividades y se dimensionarán los requerimientos de recursos para la ejecución de las mismas en el municipio.

Para la sistematización del resultado de este trabajo, se plantea el siguiente formato referencial:

PLAN DE VACUNACIÓN

MUNICIPIO:.....

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: .....

PERIODO: .....

OBJETIVO	META				ESTRATEGIA	TÁCTICAS	REQUERIMIENTOS
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4			

3.2.5 Programación de actividades

Realizado el balance de ejecución de la programación correspondiente al año en curso, tanto operativa como financiera; realizado el análisis de entorno, identificado el inventario de recursos disponibles y contando con un plan de vacunación consolidado a nivel de la red municipal de servicios de salud para la siguiente gestión, se procede con la programación de actividades y estimación de presupuesto.

Si bien las actividades del PAI, se refieren a la aplicación de vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación; debe también considerarse actividades que lleven a establecer o fortalecer los componentes obligatorios a través de los que desarrolla sus acciones; y de cuya operativa esta a cargo el municipio.

Estos componentes son:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Vacunas y jeringas	Cuantificadas en función al plan de vacunación formulado por establecimiento de salud y consolidado a nivel de red municipal de servicios de salud.
Logística	Se refiere a un sistema administrativo; que en el caso del PAI establece la normativa para garantizar la disponibilidad y correcto uso de vacunas, jeringas e insumos, en función a la población meta. La administración logística de recursos, se compone de cuatro (4) procesos esenciales: ✓ Adquisición ✓ Almacenamiento ✓ Distribución ✓ Sistema Informático Estos procesos involucran a toda la red de establecimientos de salud, con la responsabilidad de controlar a cabalidad los procedimientos internos en cada etapa, a fin de identificar factores de riesgo de pérdida de vacunas, jeringas e insumos, y minimizarlos o mejor aún evitarlos. Para ello el sistema de logística del PAI sigue el ciclo de PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MONITOREO, usando instrumentos técnicos (formularios) de uso obligatorio en todos los niveles, y para un flujo constante de información en cada etapa. (Véase Serie de Documentos Técnicos normativos del Ministerio de Salud y Deportes)
Cadena de frio	Implica un proceso o conjunto de actividades, que aseguran la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del almacén central hasta el momento de la vacunación. Fallas en la cadena de frio ocasionan que la inmunización no tenga el efecto deseado al no poder conservar las vacunas en buen estado. Los elementos fundamentales de la cadena de frio son: ● Recursos humanos debidamente capacitados ● Recursos materiales, como equipos y componentes para almacenar y transportar vacunas ● Recursos económicos, para cubrir las necesidades subsecuentes

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Vigilancia epidemiológica	Es el conjunto de acciones rutinarias y permanentes de ejecución obligatoria en todos los niveles de atención y, responsabilidad de todo el personal de salud; incluye: a) Recolección de datos sobre alcances y resultados de la acción b) Generación de respaldos verificables de la información recolectada c) Análisis y diseminación continua y sistemática de datos esenciales Estos permiten conocer el impacto de la inmunización, detectar oportunamente brotes epidémicos o importación de virus entre otros. La información que se obtiene es la base para la toma de decisiones; para planificar, implementar y evaluar estrategias y medidas de intervención para la prevención y control de las enfermedades. La vigilancia puede ser pasiva o activa: **1. Pasiva:** Surge a partir de los datos e información por las atenciones cotidianas en los establecimientos. Se sistematiza en el SNIS. **2. Activa:** Se puede realizar tanto dentro del establecimiento de salud como fuera de él, a través de la Vigilancia Comunitaria, la Vigilancia Institucional y la Vigilancia Centinela. Este tipo de vigilancia precisa una programación previa de acciones y asignación de recursos para su ejecución.
Supervisión	Proceso compuesto por acciones directas e indirectas, cuya finalidad es la verificación en sitio del cumplimiento de indicadores, normas, procedimientos y desempeño del personal de salud. En los municipios se puede aplicar la auto supervisión de los establecimientos bajo la tutela de la coordinación de red y del SEDES; o la supervisión cruzada. Sea cual sea la modalidad de supervisión aplicada en el municipio, esta debe considerar un proceso de planificación con objetivos, componentes a supervisar, muestreo de áreas a supervisar, instrumentos, cronograma y presupuesto.
Capacitación	En coordinación con otros niveles de la red de servicios de salud, a nivel municipal, programar y presupuestar espacios para consolidar conocimientos, destrezas y competencias del personal de salud en cuanto a vacunas y vacunación coadyuva al logro de objetivos y metas.

Para la ejecución de las actividades al interior de estos componentes el Ministerio de Salud y Deportes, ha diseñado y establecido herramientas técnicas de uso obligatorio en todos los niveles de atención. Estas herramientas han sido diseñadas con la visión de tener un control estricto de los recursos del PAI; el mal uso u omisión en el uso de estos instrumentos podría acarrear pérdidas al Estado, lo cual es regulado en el Reglamento del funcionario Público y la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Cada uno de estos componentes se debe traducir en actividades programables y asignándoles un grado de prioridad de ejecución, para su incorporación en el POA municipal:

PROGRAMA DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES DEL PAI

MUNICIPIO: .....

PERIODO: .....

Operación	Prioridad	Actividad	Responsable	Cronograma	Requerimiento presupuestario
Vacunas, jeringas e insumos					
Logística					
Cadena de frio					
Vigilancia epidemiológica					
Supervisión					
Capacitación					

Con actividades programadas en el marco de estos elementos como base para la planificación operativa del PAI en el nivel municipal, es momento de incorporarlo al POA y presupuesto municipal, a través de las herramientas oficialmente definidas y en los escenarios convocados por el GAM, y vinculando las operaciones a las acciones de corto plazo municipales del sector salud.

3.3 HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN DEL POA – APLICACIÓN PAI

En este acápite desarrollaremos las herramientas principales para la formulación del POA, en secuencia lógica al desarrollo del marco metodológico de la presente guía; con algunos ejemplos de aplicación para el PAI.

Los datos que se reflejan en las herramientas, no son datos reales, el objetivo es únicamente proporcionar una idea de cómo llenarlos.

2. Formulario de Seguimiento a la Ejecución Física del POA con articulación al PDES

GESTIÓN: 2023

Eje Estratégico	Meta	Resultado	Acción	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO		ACCIÓN DE CORTO PLAZO				Seguimiento a la ejecución						OBS.
						Estructura Programática			Estructura de financiamiento							
				Descripción	Producto	Descripción	Programa	Proyecto	Actividad	Fuente	Organismo Financiador	Programado (Bs)	Ejecución 1er semestre (%)	Ejecución proyectada 2do semestre (%)	Total ejecución esperada %	
6	2	1	1	Reducir el número de personas que presentan enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Población objetivo que recibe las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.	Aplicar a la población el esquema de vacunación según le corresponda		0	99	41	119	90%	40%	40%	80%	

1. Formulario de Seguimiento a la Ejecución Física del POA con articulación al PDES

MUNICIPIO:
GESTIÓN: 2023
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA

PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO		ACCIÓN DE CORTO PLAZO			INDICADOR				SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN					
Eje Estratégico	Meta	Resultado	Acción	Descripción	Resultado / Producto	Cód.	Descripción	Ponderación de prioridad	Descripción	Unidad de medida	Línea de base	Fuente de verificación	Meta Total programada	Ejecución 1er semestre (%)	Ejecución proyectada 2do semestre (%)	Total ejecución esperada %	OBS.
6	2	1	1	Reducir el número de personas que presentan enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Población objetivo que recibe las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.		Aplicar a la población el esquema de vacunación según le corresponda	1	Cobertura de vacunación con la 1da dosis de pentavalente	%	70%	SUIS	90%	35%	30%	65%	
									Cobertura de vacunación con la 3ra dosis de pentavalente	%							
									Cobertura de vacunación con 2da dosis de la SRP	%							
									Cobertura de vacunación con esquema completo en niñas y niños < 1 año	%							
									Cobertura de vacunación anti polio en < de 1 año	%							
									Cobertura de vacunación con esquema completo en niños y niñas de 1 año	%							
									Cobertura de vacunación con la 2da dosis de la vacuna VPH	%							
6	2	1	1	Incrementar el porcentaje de establecimientos de salud que reportan información al SUIS	Establecimientos de salud reportando al SUIS		Asegurar que los establecimientos reportan información al SUIS		Porcentaje de establecimientos que reportan información al SUIS	%	55%	SUIS	100%	55%	30%	85%	
6	1	1	1	Fortalecer y equipar establecimientos de salud de primer nivel del subsector público	Número de establecimientos de salud de 1er nivel del subsector público con cadena de frio		Homogenizar el equipamiento necesario para el PAI en todos los establecimientos de salus del municipio		Establecimientos de salud municipales adecuadamente equipados para atender el PAI	Cant.	10	Inventario municipal	30	15	10	25	

4. Formulario de Programación de Operaciones y Actividades - PAI

En esta herramienta se desagrega las operaciones y se las articula al PDES, con lo que se facilita la incorporación en el POA municipal.

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES Y ACTIVIDADES PAI

MUNICIPIO:
GESTIÓN: 2024

ACCIÓN DE CORTO PLAZO			OPERACIONES																		Actividad	Fecha prevista de inicio	Fecha prevista de finalización	Responsable (Unidad /Cargo)	Fuente de verificación
Cód.	Descripción	Producto	Cód.	Descripción	Tipo de Operación		Programación mensual													Total					
					Func.	Inv.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	Aplicar a la población el esquema de vacunación según le corresponda	Población objetivo que recibe las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.		Vacunación en consultorio	X		650	650	700	700	650	700	650	650	700	650	650	650	650	8000	Gestión para la dotación de vacunas	ene	dic	Personal de enfermería	SUIS
				Reuniones con la comunidad	X			1		1		1		1		1			1	6	Gestión para dotación de jeringas	feb	dic	Responsable PAI	Acta de reunión
				Rastrillaje	X			1			1			1						3	Dotación de insumos	feb	sept	Personal de enfermería	Ficha de información
				Campañas de vacunación	X				1				1				1			3	Dotación de material de escritorio	marz	nov	Responsable PAI	Informes
																					Rastrillaje				
																					Programación de visitas a comunidades				
																					Visitas a las comunidades				

3. Matriz de Sistematización preliminar de operaciones - PAI

Realizado el trabajo de balance de la gestión en curso, análisis de entorno y la formulación del plan de vacunación para la siguiente gestión; entre los actores directamente involucrados con el PAI, se propone el uso de la siguiente matriz:

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE OPERACIONES - PAI MUNICIPAL

Municipio:
Periodo:

Luchar y fecha:

Operación	Objetivos	Metas	Estratégias	Recursos disponibles	Actividades	Cronograma	Requerimientos	Costo (Bs)	Responsable
Vacunas, Jeringas e insumos	Vacunación de la población con el esquema completo	80%	Vacunación permanente en establecimientos de salud	20 establecimientos de primer nivel para 10000 habitantes del municipio	Gestión para la dotación de vacunas	ene - dic	7400 vacunas	12,000.00	Responsable PAI
				3 termos	Dotación de jeringas	ene - dic	7400 jeringas	8,000.00	Responsable PAI
				600 vacunas	Dotación de insumos	ene - dic	insumos	3,500.00	Responsable PAI
			Vacunación intensiva a través de campañas		Dotación de material de escritorio	ene - dic			Responsable PAI
					Rastrillaje				Personal de enfermería
					Programación de visitas a comunidades	marzo / junio / noviembre	material de escritorio	600.00	Responsable PAI
					Visitas a las comunidades	abril / julio / diciembre			Responsable PAI
Logística	Transportar adecuadamente las vacunas, jeringas e insumos	100%	Uso de vehiculo institucional	1 vehiculo de transporte	Programar la dotación	ene - dic	gasolina	2,500.00	Responsable PAI
Cadena de frio									

MUNICIPIO
GESTIÓN : 2024

ARTICULACIÓN DE ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y ACCIONES DE CORTO PLAZO

FECHA: .....

Cod. PDES				ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO		ACCIÓN DE CORTO PLAZO		INDICADORES				PROGRAMACIÓN DE METAS				RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	
Eje Estratégico				Denominación	Producto o Resultado	Cod.	Denominación	Producto	Descripción	Unidad de Medida	Fórmula	Línea base	Estimación 2023	Programación 2024	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Meta																				
Resultado																				
Acción																				
6	2	1	1	Reducir el número de personas que presentan enfermedades transmisibles y no transmisibles.	Población objetivo que recibe las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.		Aplicar a la población el esquema de vacunación según le corresponda	Población objetivo que recibe las vacunas de acuerdo al esquema de vacunación.	Cobertura de vacunación con la 1ra dosis de pentaelente			65%	65%	90%	25%	20%	25%	20%	MAE	
									Cobertura de vacunación con la 3ra dosis de pentaelente										RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	
									Cobertura de vacunación con 2da dosis de la SRP										RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	
									Cobertura de vacunación con esquema completo en niñas y niños < 1 año										RESPONSABLE QUE ELABORA	
									Cobertura de vacunación anti polio en < de 1 año											
									Cobertura de vacunación con esquema completo en niños y niñas de 1 año											

5. Formulario de Articulación de Acciones de Mediano Plazo y Acciones de Corto Plazo – POA Municipal

Este formulario muestra cómo las acciones de corto plazo del municipio se articulan a las acciones de mediano plazo.

6. Memorias de Cálculo:

Estos formularios coadyuvan a que cada área/unidad organizacional o programa con el desglose los requerimientos para ejecutar sus operaciones y acciones, expresado en recursos financieros.

Por cada objeto de gasto, se genera una memoria de cálculo diferente.

MUNICIPIO:
UNIDAD ORGANIZACIONAL / PROGRAMA .....

MEMORIA DE CÁLCULO 2024
OBJETO DEL GASTO: RECURSOS HUMANOS

Operación		Descripción del cargo	Profesión u oficio	Cantidad funcionarios				Tiempo (Meses / Hombre)	Fecha en la que se requiere	Costo (Bs)	
				Permanentes		Temporales (< 4 meses)					
Cod.	Descripción			Existentes	Requeridos	Existentes	Requeridos			Unitario	Total
TOTAL OBJETO DE GASTO											

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Elaborado por:	
Aprobado por:	

7. Presupuesto de Recursos:

Para la aplicación de esta herramienta, se debe recurrir a los Clasificadores Presupuestarios del MEFP (Véase anexo No. 2) donde se encuentran los códigos asignados a las Fuentes de Financiamiento y a los Organismos Financiadores, además de la desagregación de los rubros.

PRESUPUESTO DE RECURSOS

PERIODO

MUNICIPIO

GRUPO / RUBRO	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	MONTO
11000	INGRESOS DE OPERACIÓN	20	230	
12000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
13000	INGRESOS POR IMPUESTOS	20	210	
14000	REGALIAS			
15000	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS			
16000	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD			
17000	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
18000	DONACIONES CORRIENTES			
19000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	80	317	
22000	DONACIONES DE CAPITAL	41	119	
23000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
32000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO			
33000	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO			
35000	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
36000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISO			
37000	OBTENCIÓN DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR			
38000	EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA			
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL			
	TOTAL			

RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
MAE		
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN		
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO		
RESPONSABLE QUE ELABORA		

Lugar y fecha

MUNICIPIO:

UNIDAD ORGANIZACIONAL / PROGRAMA .....

MEMORIA DE CÁLCULO 2024

OBJETO DEL GASTO: BIENES Y SERVICIOS

Cod.	Operación Descripción	Descripción de bienes y servicios	Unidad de medida	Cantidad Existentes	Cantidad Requeridos	Cantidad Total	Fecha requerida	Partida presupuestaria	Costo (Bs) Unitario	Costo (Bs) Total
	TOTAL									

Elaborado por:

Aprobado por:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA

MUNICIPIO:

UNIDAD ORGANIZACIONAL / PROGRAMA .....

MEMORIA DE CÁLCULO 2024

OBJETO DEL GASTO: ACTIVOS FIJOS

Cod.	Operación Descripción	Descripción de Activos Fijos	Unidad de medida	Cantidad Existentes	Cantidad Requeridos	Cantidad Total	Fecha requerida	Partida presupuestaria	Costo (Bs) Unitario	Costo (Bs) Total
	TOTAL									

Elaborado por:

Aprobado por:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA

PROGRAMACIÓN FINANCIERA PARA LAS OPERACIONES DE CORTO PLAZO

MUNICIPIO:
GESTIÓN:

ACCIÓN DE CORTO PLAZO					OPERACIONES				ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					Programación mensual (Bs)											TOTAL
Cód.	Descripción	Producto	Unidad Responsable	Cód.	Descripción	Tipo de Operación		Ponderación	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Func.	Inv.		Programa	Proyecto	Actividad	Fuente	Organismo Financiador													

10. Formulario de Articulación de la Programación Financiera de las Acciones de Mediano Plazo y las Acciones de Corto Plazo

Esta herramienta permite sistematizar la programación financiera del municipio, articulando con la planificación de mediano plazo.

ARTICULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES DE MEDIANO PLAZO Y LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO

MUNICIPIO:
GESTIÓN:

PDES			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO			ACCIÓN DE CORTO PLAZO					ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA				Presupuesto (Bs)	RESPONSABLES DE LOS COMPROMISOS	
Eje Estratégico			Cod.	Descripción	Producto	Cód.	Descripción	Producto	Unidad Responsable	ESTRUCTURA PROGRAMATICA			ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO			NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Meta										Programa	Proyecto	Actividad	Fuente	Organismo Financiador			
Resultado																	
Acción																	
																MAE	
																RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN	
																RESPONSABLE DE PRESUPUESTO	
																RESPONSABLE QUE ELABORA	

4 MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y COMPETENCIAS PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y EL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

a. Constitución Política del Estado

Establece que la primera función del Estado es “Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana”; integrando e incorporando a todas las Entidades Territoriales Autónomas ETA.

En el Art. 302 indica que es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal GAM, planificar y promover el desarrollo humano de su jurisdicción; garantizar que la planificación del desarrollo municipal este en concordancia con la planificación departamental y nacional.

b. Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización (19 de julio de 2010)

Esta norma determina que los gobiernos autónomos tienen como fin “Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del pueblo, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional.

Con fines de incorporación de su presupuesto en el Presupuesto General del Estado, las ETAs tienen la obligación de presentar en plazos definidos previamente; a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado, el Plan Operativo Anual y el presupuesto anual aprobados por sus respectivos niveles legislativos.

c. Ley No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales (9 de enero de 2014)

Esta ley, instruye a los GAM la aplicación de las Directrices de Planificación del órgano rector para elaborar y articular los planes de largo, mediano y corto plazo; debiendo generar instancias o espacios formales de participación y control social, para el pronunciamiento sobre la formulación del POA y el presupuesto institucional y sus reformulados, entre otros.

Establece que el Concejo Municipal es el encargado de aprobar el POA, el presupuesto municipal y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el Alcalde.

d. Ley No. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE (21 de enero de 2016)

Establece el SPIE como el mecanismo que conduce el proceso de planificación del Estado a través de un conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo en todos los niveles.

Define el Subsistema de Planificación (SP) y establece que el PGDES y el PDES son de cumplimiento obligatorio para las entidades del Estado. El PGDES se constituye en el Plan de mayor jerarquía y se implementa a través del PDES, del cual se desprenden todos los planes de mediano plazo del SPIE y de éstos, los de corto plazo, que están constituidos por los POAs con un horizonte de un (1) año, contemplando la definición de acciones anuales, metas, resultados, operaciones, la estimación de tiempos de ejecución, recursos financieros necesarios, responsables.

e. Ley No. 1178 de Administración y Control Gubernamental (20 de julio de 1990)

Esta ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con el SPIE, con el objeto de programar, organizar y controlar la captación y uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, las prestaciones de servicios y los proyectos del Sector Público.

Define, entre otros; el Sistema de Programación de Operaciones SPO y el Sistema de Presupuesto SP como marcos regulatorios de aplicación obligatoria:

- ✓ Artículo 6.- “El SPO traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el SPIE, en resultados concretos a alcanzar en el mediano y corto plazo …” de acuerdo con las Normas Básicas correspondientes (D.S. No. 3246 de 5 de julio de 2017).
- ✓ Artículo 8.- “El SP preverá en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada” de acuerdo con las Normas Básicas correspondientes (R.S. No. 217095 de 4 de julio de 1997).

f. Ley No. 1407 PDES 2021 – 2025 (9 de noviembre de 2021)

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 se constituye en el plan de mediano plazo del Estado Plurinacional de Bolivia. Se organiza en 10 ejes estratégicos articulados con los 13 pilares de la Agenta Patriótica 2025 (PGDES) y establece metas, resultados y acciones para avanzar en el cumplimiento de dicha agenda. Estos se encuentran sistematizados en la “ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA”, que es la guía de aplicación obligatoria para elaborar los planes de todas las instituciones del Estado.

g. Directrices presupuestarias

Anualmente, el MEFP y el MPD a través de Resolución Bi Ministerial hacen públicas las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión correspondiente, cuyo objeto es establecer los lineamientos generales y específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales de las entidades del sector público para el corto y mediano plazo, articulado al PDES.

5 MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN Y DESIGNACIÓN DE COMPETENCIAS

a. Constitución Política del Estado

En el Art. 18 se reconoce y establece que todas las personas tienen derecho a la salud; que el Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna, instaurando la universalidad del Sistema Único de Salud, gratuito, equitativo, intracultural, participativo, con calidad, calidez y control social.

En el Art. 37 indica que se prioriza la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

b. Ley No. 031 Marco de Autonomías y Descentralización (19 de julio de 2010)

En el Art. 81 se establecen las competencias de todos los niveles del Estado respecto a la salud. Para los GAM, entre otras, establece las competencias de Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención de la Red Municipal SAFCI, dotarles de todo lo necesario para su correcto funcionamiento; ejecutar el componente de atención de salud, haciendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y proporcionar información al SUIS.

c. Ley No. 1152 Hacia el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (20 febrero de 2019)

Su ámbito de aplicación cubre el nivel central del Estado, las ETAs y las Entidades del Subsector Público de Salud; en el marco de la universalidad y gratuidad de la salud; y la Política SAFCI.

En el Art. 10 se establece que los GAM financiarán la atención a su población en el Primer y Segundo Nivel de Atención con los recursos provenientes del quince punto cinco por ciento (15.5%) de la Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente del IDH y destinarán un porcentaje mayor u otros recursos adicionales, cuando el mismo sea insuficiente.

En caso de existir saldos anuales acumulados en la "Cuenta de Salud Universal y Gratuita", serán reprogramados para las atenciones de salud de la siguiente gestión o podrán ser utilizados en el siguiente orden de prioridades: Fortalecimiento de equipamiento e infraestructura en salud, Programas especiales de salud o Contratación de recursos humanos de los establecimientos de salud.

d. Ley No. 3300 de Vacunas (12 de diciembre de 2005)

En el Art. 2, el Estado declara de interés nacional todas las actividades relacionadas con la inmunización de enfermedades prevenibles.

En el Art. 16, garantiza el financiamiento para la adquisición de vacunas y otros suministros a través de la Ley del Presupuesto General de la Nación.

e. Ley No. 3058 de Hidrocarburos (17 de mayo de 2005)

El Art. 57, sobre la Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, indica que éste será coparticipado; y para el caso de los GAM, indica:

"El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros". Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por el IDH, a los sectores de educación, salud …

f. Resolución Ministerial No. 0251 del Ministerio de Salud y Deportes – Reglamento para la Aplicación técnica y Gestión Administrativa y Financiera de la Ley No. 1152 (30 de junio de 2021)

Tiene por objeto establecer el marco normativo para la aplicación técnica y la gestión administrativa y financiera de la Ley No. 1152.

En el Art. 3 identifica responsables y funciones de la implementación y aplicación del SUS; designando en los Gobiernos Autónomos Municipales la responsabilidad de:

- ✓ Administrar los establecimientos de salud de su jurisdicción, garantizando la disponibilidad permanente y oportuna de medicamentos e insumos, la dotación de materiales, infraestructura y equipamiento, así como el mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias.
- ✓ Establecer el presupuesto anual destinado al funcionamiento del SUS para cada establecimiento de salud municipal con los recursos señalados en la Ley 1152, garantizando mínimamente el 15.5% de la coparticipación tributaria municipal o el equivalente del IDH municipal.
- ✓ En el marco de la gestión participativa y Control Social en Salud de la SAFCI, elaborar con el sector salud, los equipos técnicos sociales en salud, la estructura social de salud del municipio, la coordinación de red correspondiente y otros sectores del desarrollo; el POA, presupuesto y PAC alineados al Plan Municipal de Salud.

REFERENCIAS ADICIONALES

Programa Ampliado de Inmunizaciones; https://www.pai.minsalud.gob.bo

Manual Técnico PAI-Publicación 356

Documentos Técnico - Normativos PAI; https://www.pai.minsalud.gob.bo/página/73

ANEXOS

ANEXO No. 1 Formulario de Supervisión PAI - Nivel Local
ANEXO No. 2 Estructura Programática del PDES - Eje 6/Meta 1 (SALUD)
ANEXO No. 3 Estructura Programática de Gastos de los GAMs
ANEXO No. 4 Clasificador de Fuentes de Financiamiento - Versión sintética
ANEXO No. 5 Clasificador de Organismos Finanacieron - Versión sintética

ANEXO No. 1

FORMULARIO DE SUPERVISIÓN PAI - NIVEL LOCAL

SEDES:	Población Total		Cob. Por vacunas	Porcentajes		
	Población menor de un añ		BCG			
Coordinación de Red	Población de 12 a 23 mes		Pentavalente	1ra	2da	3ra
	Población de 4 años		Antipolio	1ra	2da	3ra
Municipio	Población mujeres de 10 a 49 años		Antirotavirus	1ra	2da	
	Población varones de 10 a 49 años		Antineumológica	1ra	2da	3ra
No. Establecimientos:	Población de mayores de 65 años		SRP:			
	Embarazos esperados		Antiomanica			
Fecha de supervisión:	Fuente:		dT mujeres 10 a 49 años	1ra	2da	3ra
	Penta 4ta dosis ..... 5ta dosis		dT hombres 10 a 49 años	1ra	2da	3ra
	Antipolio 4ta dosis ..... 5ta dosis		Datos de cobertura desde ...../...../..... Al ...../...../.....			

COMPONENTE	VARIABLES	SI	NO	OBSERVACIONES
I CADENA DE FRIO	Cuenta con ambiente exclusivo de cadena de frio y almacen en seco y el extinguidor?			
	Refrigerador y/o congelador exclusivo para vacunas?			
	Refrigerador a 15 cm de la pared, nivelada, en la sombra, con la rejilla y tarima de madera?			
	Cuenta con estabilizador de energia exclusivo para el refrigerador?			
	Tiene paquetes frios suficientes y bien organizados en el congelador o evaporador?			
	Tiene paquetes frios como estabilizadores de temperatura suficientes y organizados en la parte inferior?			
	Las vacunas son almacenadas en los canastillos, de acuerdo a la capacidad instalada?			
	Conoce como sacar la capacidad de equipos de refrigeracion y almacen en seco?			
	Existe 2 termómetros dentro del refrigerador en buen estado y ubicados encima de las vacunas en los espacios correspondientes?			
	Hoja de temperatura visible, actualizada hasta hoy, entre +2 y +8 ºC? (incluye fines de semana y feriados),			
	Se registra y analiza las temperaturas de riesgo?			
	Tiene archivado las hojas de temperatura de hace 5 años atrás y con visto bueno del inmediato superior?			
	Tiene Stiker de consejos útiles y alta prioridad en el refrigerador?			
	Cuenta con termos y termometros para actividad extramural e intramural en buen estado?			
	Cumple con el control de temperatura registrada de los termos para la vacunacion dentro y fuera de servicio?			
	Cuenta con cajas frias o conservadores para el recojo de las vacunas?			
	Cuenta con el registro de temperatura de recojo y llegada de las vacunas al establecimiento de salud?			
	Cuenta con plan de contingencia de cadena de frio?			
	Cuenta con plan de emergencia si falla la cadena de frío de acuerdo a norma establecida?			
	Realiza limpieza interna y externa cada mes y se encuentra registrado en la hoja de vida del refrigerador?			
	Aplica el acondicionamiento de paquetes frios en el termo para la vacunación dentro y fuera de servicio?			
	Realiza inventario de equipos de cadena de frío: refrigerador, termos y paquetes			
II. VACUNAS, JERINGAS Y BIOSEGURIDAD	Cuenta con ambiente exclusivo de cadena de frio y almacen en seco y el extinguidor?			
	Las vacunas estan organizadas en los canastillos de acuerdo a su sensibilidad al frio y calor en el refrigerador?			
	Las Vacunas estan organizadas por fechas de seguridad (principio PEPS)?			
	Frascos abiertos de vacunas multidosis tiene fecha y hora de apertura?			
	El vacunador cumple con la norma de NO dejar insertas agujas en frascos de vacunas multidosis?			
	Tiene conocimiento de la prueba de agitación (congelamiento)?			
	Utiliza una jeringa por cada frasco para dilusion/reconstitucion de acuerdo a norma?			
	Utiliza el diluyente especifico para cada lote de vacuna?			
	Cumple con la norma de administracion de las vacunas aplicando correctamente; edad, vacuna y diluyente especifico, via y cantidad			
	Conoce las contraindicaciones de cada una de las vacunas?			
	Cumple con las instrucciones de las cajas de desecho?			
	Cumple con la norma de bioseguridad para la eliminacion de los residuos solidos, generados en la vacunación?			

COMPONENTE	VARIABLES	SI	NO	OBSERVACIONES
III. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN	El vacunatorio se encuentra ubicado en un lugar accesible, visible e identificado?			
	Tiene mapa/croquis e isocronas del área, actualizado y visible?			
	Cuenta con censo de Unidades Educativas, guarderias, asilos y otras instituciones			
	Coordina con instituciones para las actividades de vacunación, por localidad/comunidad en guarderias, Unidad Educativa, ONGs y otras ?			
	Tiene cronograma de actividades de vacunación, por localidad /comunidad en guarderias, Unidad Educativa y otros?			
	Coordina con la estructura social (ALS, CLS, juntas vecinales, asociación de padres de familia y con los programas Mi Salud, BJA, Nutricion, Telesalud y otros)			
	Tiene actividades de vacunación y vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles inserto en el POA del Municipio?			
	Cumple el Municipio con el financiamiento comprometido para actividades PAI?			
	Cuenta con ambiente exclusivo de cadena de frio y almacen en seco y el extinguidor? (Vale 2 puntos			
	En el cuaderno de charlas educativas, se encuentra temas del PAI?			
IV. LOGÍSTICA	Tiene programación anual y trimestral de todas las vacunas, jeringas y cajas de desecho de acuerdo a norma establecida?			
	Los formularios de logística (programación, requerimiento, despacho, kardex e informes de uso y perdida) estan correctamente llenados y con visto bueno del inmediato superior?			
	Envia a nivel superior, los informes mensuales de uso y perdida de vacunas y jeringas de forma oportuna conjuntamente con los informes del SNIS ?			
	Se analizan los factores de pérdida por tipo de vacuna y jeringas de forma mensual?			
	Tiene kardex actualizado diario de vacunas, diluyentes, jeringas y cajas de desecho?			
	Los saldos del kardex coincide con el inventario fisico de vacunas y diluyentes			
V. CALIDAD DE INFORMACIÓN	Realiza control de calidad del numero de vacunados con el SNIS y reporte de uso de vacunas y jeringas?			
	Coinciden los datos del cuaderno de vacunación/SOAP con el informe mensual del SNIS/ ?			
VI. OPORTUNIDADES DE VACUNACIÓN	Vacuna todos los dias todas las vacunas?			
	Existe integralidad en la aplicación de vacunas pentavalente con IPV, rotavirus y neumococo.			
	El centro de salud tiene una estrategia para anotar la próxima cita de vacunación (Carnet de Salud Infantil u otro)			
	En el Carnet de Salud Infantil se identifica el Centro de Salud que administrò la dosis de vacuna correspondiente: (p.ej sello y otro)			
	Investigan el estado vacunal de todos los niños que llegan al servicio?			
	Utiliza el gavetero u otro sistema de seguimiento (Carpetas familiar con señalizacion para hacer seguimiento)			
VII. ANALISIS DE COBERTURAS	Tiene cuadro de monitoreo de coberturas actualizado y graficado de todas las vacunas?			
	Establecimiento de Salud lograrà cumplir con el 95% de coberturas para todas las vacunas en la presente gestion?			
	La tasa de deserción con penta 3 es igual o menor a 5%			
	Realiza vacunación en servicio			
	Realiza vacunación fuera de servicio			
	Periódicamente, se analiza la situación del PAI con todos los indicadores?			

COMPONENTE	VARIABLES	SI	NO	OBSERVACIONES
VIII. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Realizan notificación semanal negativa de las EPV y ESAVIS?			
	Conoce la definición de caso sospechosos de Sarampión / rubeola, SRC?			
	Conoce la definición de caso sospechosos de poliomielitis?			
	Conoce la definición de caso sospechosos de Fiebre Amarilla, tosferina, difteria y ESAVI?			
	En que tiempo y que tipo de muestra se debe tomar en caso sospechoso de sarampión /rubéola,SRC Poliomielitis, Fiebre amarilla, tosferina y difteria ?			
	Notificaron e investigaron casos sospechosos de enfermedades inmunoprevenibles y ESAVI (moderado y grave)?			
	Realiza y consolida mensualmente las busquedas activas institucionales?			
	Realiza y consolida mensualmente las búsquedas activas comunitarias y Monitoreos Rapidos de Coberturas?			
	Conoce y cuales son los indicadores de vigilancia del sarampión y poliomielitis?			
	Cumple con los indicadores de vigilancia de sarampion y poliomielitis?			
	Realizo la socializacion sobre Vigilancia Epidemiologica Comunitaria a los Autoridades Locales de Salud?			
	Cuenta con fichas epidemiológicas de enfermedades inmunoprevenibles y ESAVIs actualizadas?, están disponibles en el fichero y en consultorios medicos?			
	Cuenta con mapeo de riesgo epidemiologico?			
	Dispone de cartilla de Vigilancia Epidemiológica			
IX. CAPACITACIÓN	Cuenta con los manuales y el CD interactivo del PAI			
	Recibieron capacitación /actualizacion?			
	En la capacitación, incluyó: Cadena de frío, logistica, vacunación segura, vigilancia epidemiologica, nuevas vacunas, campañas?			
X. SUPERVISIÓN	Recibio supervisión PAI en el último semestre del nivel inmediato?			
	Cumplieron con la mejora de las debilidades encontradas?			
	Durante el ultimo semestre se realizo la autosupervision?			
XI. INVENTARIO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRIO	Se realizo una nueva compra del refrigerador o refrigeradores en el ultimo semestre? Fecha……			

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD		SERIE	REFRIGERANTE
			Refrigerador (Lts) 50%	Congelador (Lts) 67%		
Refrigerador 1						
Refrigerador 2						
Refrigerador 3						
Termo						
Termo						
Termometros						
Paquetes frios						
Datos de equipos almacenados						

XI. OBSERVACIONES	COMENTARIOS, FORTALEZAS ENCONTRADAS Y/O COMPROMISOS DE MEJORA A CUMPLIR	RESPONSABLES	FECHAS DE EJECUCIÓN

Nombre del supervisor …… (y) ……

Nombre del entrevistado …… (y) ……

Fecha de supervisión:

ANEXO No. 2

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES 2021-2025

EJE ESTRATÉGICO 6 "Salud y Deportes para Proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia"

Sólo Salud

EJE	META	RESULTADO	ACCIÓN	TIPO	DESCRIPCIÓN
6				EJE	Salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia
6	1			META	Prevenir la propagación y el impacto negativo de la COVID-19 con un enfoque preventido que amplie la cobertura de la inmunización hacia su universalización
6	**1**	**1**		**RESULTADO**	**Se ha reducido la letalidad del COVID-19 y el impacto negativo de las emergencias sanitarias, mediante inmunización preventiva.**
6	1	1	1	ACCIÓN	Implementar el Plan Nacional de Vacunación para disminuir la mortalidad causada por la COVID-19, avanzando hacia la inmunización de la población desde su nacimiento.
6	1	1	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	2			META	Fortalecer y universalizar la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que prioriza la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los tres niveles de atención, recuperando la medicina tradicional ancestral.
6	**2**	**1**		**RESULTADO**	**Se han reducido las enfermedades transmisibles y no transmisibles en base a la política nacional de salud (SAFCI), que prioriza la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.**
6	2	1	1	ACCIÓN	Reducir el número de personas que presentan enfermedades transmisibles y no transmisibles
6	2	1	2	ACCIÓN	Incrementar el procentaje de las atenciones médicas de salud preventiva a travbés del programa MI SALUD/SAFCI
6	2	1	3	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	**2**	**2**		**RESULTADO**	**Se ha implementado el Sistema Unico de Información en Salud (SUIS) en el Sistema Nacional de Salud**
6	2	2	1	ACCIÓN	Incrementar el porcentaje de establecimientos de salud que reportan inforamción al Sistema Único de Información en Salud
6	2	2	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	**2**	**3**		**RESULTADO**	**Se ha fortalecido el control social para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en el marco de la política SAFCI**
6	2	3	1	ACCIÓN	Incrementar el número de Concejos Sociales de Salud que desarrollan acciones de promoción de la Salud y prevención de las enfermedades.
6	2	3	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	**2**	**4**		**RESULTADO**	**Se ha revalorizado la medicina tradicional y ancestral boliviana**
6	2	4	1	ACCIÓN	Incrementar el número de prestadores de medicina tradicional con registro y matrícula.
6	2	4	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	**2**	**5**		**RESULTADO**	**Se ha implementado una estrategia de evaluación de calidad a los servicios**
6	2	5	1	ACCIÓN	Implementar un sistema de evaluación de la calidad en la atención a los servicios en salud
6	2	5	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	3			META	Fortalecer el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito a través de servicios de salud públicos, respetando su cosmovisión y prácticas tradicionales sin exclusión ni discriminación en el marco de la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural vigente SAFCI
6	**3**	**1**		**RESULTADO**	**Se ha incrementado el acceso a la población a servicios de salud SUS**
6	3	1	1	ACCIÓN	Incrementar el procentaje de población beneficiaria que accede a la atención del SUS
6	3	1	2	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado
6	4			META	Promover la especialización de profesionales médicos destinado a cubrir las necesidades de servicios hospitalarios para los centros de salud de segundo, tercer y cuarto nivel a ser construidos y equipados.
6	**4**	**1**		**RESULTADO**	**Se ha fortalecido el recurso humano en el área de la salud el Sistema Nacional de Residencia Médica (SNRM)**
6	4	1	1	ACCIÓN	Incrementar la oferta de establecimientos de salud para la formación de especialistas en el marco del Sistema Nacional de Residencia Médica SNRM
6	4	1	2	ACCIÓN	Incrementar la cantidad de profesionales médicos especializados en salud
6	4	1	3	ACCIÓN	Otras acciones que aporten al logro del resultado

FUENTE: Directrices de Formulación Presupuestaria 2024

ANEXO No. 3

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE GASTOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES E INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS

CÓD.	DENOMINACIÓN DE PROGRAMA	FINALIDAD Y FUNCIÓN	SECTOR ECONÓMICO
0	FUNCIONAMIENTO ÓRGANO EJECUTIVO	1.1.1	14
1	FUNCIONAMIENTO ÓRGANO DELIBERATIVO	1.1.1	14
02 – 09	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.1.1	14
100 – 109 (*)	PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	4.2; 10.9.1	1
110 - 119	SANEAMIENTO BÁSICO	5.2; 6.3	10
120 – 129	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE RIEGO Y/O MICRORIEGO	4.2.1	1
130 – 139	DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5	19
140 – 149	ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.1	10
150 – 159	FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN	4.3.5; 4.3.6	5
160 – 169	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6.4	11
170 – 179	INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL	4.4.3; 4.5.1; 6.1	11
180 – 189	GESTIÓN DE CAMINOS VECINALES	4.5.1	6
190 – 199	SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL	6.1; 6.2; 4.9	11
200 – 209	GESTIÓN DE SALUD	7; 10.4.1; 10.9.1; 10.9.2	8
	200 00 99 Servicios de Salud Universal y Gratuita – SUS	7.4	8.3.2
	200 00 104 Salud Renal – SUS	7.3.2	8.3.2
	200 00 105 Lucha Contra el Cáncer – SUS	7.3.2	8.3.2
	200 00 150 Prevención, Control y Atención del Coronavirus		
210 – 219	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	9; 10.9.1; 10.9.2	9
	210 00 88 Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica	9.8	9.5.1
220 - 229	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	8.1; 8.6; 10.9.1	24
230 – 239	PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO	8.2; 8.6; 10.9.1	22
240 – 249	DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO	4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 10.9.1	20
250 - 259	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER	10.9.1; 10.9.2; 10.1; 10.2; 10.4.1	21; 23
	250 00 60-70 Otras actividades contra la violencia hacia la mujer	10.9.1; 10.9.2	23.1.5
	250 00 81 Otras actividades en beneficio de las personas con Discapacidad	10.1.2	21.3
	250 00 88 Renta Dignidad	10.2	21.2.1
	250 00 89 Ayuda Económica para Personas con Discapacidad	10.1.2	21.3.2
251	PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER - PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	10.9.1	23.1.5
260 – 269	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10.4.1; 10.9.1; 10.9.2	21; 23
270 – 279	VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	4.5.1	6
280 – 289	DEFENSA DEL CONSUMIDOR	4.1.1; 4.7.1	13
290 – 299	SERVICIO DE FAENADO DE GANADO	4.2.4; 4.9	1
300 – 309	SERVICIO DE INHUMACIÓN, EXHUMACIÓN, CREMACIÓN Y TRASLADO DE RESTOS	6.1; 6.2	11

FUENTE: Directrices de formulación presupuestaria 2024

ANEXO No. 4

CLASIFICADOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Versión Sintética

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SIGLA
10	Tesoro General de la Nación	TGN
41	Transferencias T.G.N.	TRANSF-TGN
91	Préstamos T.G.N.	PREST-TGN
11	T.G.N. Otros Ingresos	TGN-OTI
46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos	TRANSF-TGN-OTI
96	Préstamos T.G.N. Otros Ingresos	PREST-OTI
20	Recursos Específicos	RECESP
42	Transferencias de Recursos Específicos	TRANS-REC-ESP
92	Préstamos de Recursos Específicos	PREST-REC-ESP
70	Crédito Externo	CREDEX
43	Transferencias de Crédito Externo	TRANSF-CRED-EX
93	Préstamos de Crédito Externo	PREST-CRE
80	Donación Externa	DON-EXT
44	Transferencias de Donación Externa	TRANSF-DON-EXT
94	Préstamos de Donación Externa	PREST-DON-EXT
87	Donación Interna	DON-INT
47	Transferencia de Donación Interna	TRANSF-DON-INT
97	Préstamos de Donación Interna	PREST-DON-INT
90	Crédito Interno	CRED-INT
45	Transferencias de Crédito Interno	TRANSF-CRED-INT
95	Préstamos de Crédito Interno	PREST-CRED-INT

FUENTE: Clasificadores Presupuestarios 2024

ANEXO No. 5

CLASIFICADOR DE ORGANISMOS FINANCIADORES
Versión Sintética

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SIGLA
	ORGANISMOS FINANCIADORES INTERNOS	**OFI**
	Gobierno	**GOB**
111	Tesoro General de la Nación	TGN
112	Tesoro General de la Nación – Papeles	TGN-P
113	Tesoro General de la Nación – Coparticipación Tributaria	TGN-CT
114	Recursos de Contravalor	RECON
116	Tesoro General de la Nación – Fondo de Compensación Departamental	TGN-FCOMP
117	Tesoro General de la Nación – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados	TGN-IEHD
119	Tesoro General de la Nación – Impuesto Directo a los Hidrocarburos	TGN-IDH
120	Tesoro General de la Nación – Impuesto a la Participación en Juegos	TGN-IPJ
121	Tesoro General de la Nación – Patentes Petroleras	TGN-PPET
129	Otros Organismos Financiadores del Gobierno	OT-GOB
000	**TGN Otros Ingresos**	**TGN-OT**
	Organismos de Recursos Específicos	**ORG-RECESP**
210	Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino	RECESP
220	Regalías	REG
230	Otros Recursos Específicos	OTPRO
	ORGANISMOS FINANCIADORES EXTERNOS	**OFE**
	Organismos Multilaterales	**MULT**
311	Asociación Latinoamericana de Integración	ALADI
312	Centro Internacional de Agricultura Tropical	CIAT
313	Comisión Económica para América Latina	CEPAL
314	Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina	CAF
315	Fondo Andino de Reserva	FAR
316	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura	IICA
317	Comunidad Andina	CAN
318	Organización de los Estados Americanos	OEA
319	Organización Latinoamericana de Energía	OLADE
321	Organización Panamericana de la Salud	OPS
322	Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe	SELA
323	Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe	FILAC
341	Programa de las NN.UU. para los Asentamientos Humanos	ONU-HABITAT
343	Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo de las Naciones Unidas	DTCD

FUENTE: Clasificadores Presupuestarios 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SIGLA
344	Fondo de las NN.UU. para la Infancia	UNICEF
345	Fondo de Población de las Naciones Unidas	UNFPA
346	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola	FIDA
347	Instituto de NN.UU. para Formación Profesional e Investigaciones	UNITAR
348	Organización de Aviación Civil Internacional	OACI
349	Organización de las NN.UU. para el Desarrollo Industrial	ONUDI
351	Organización de las NN.UU. para la Agricultura y la Alimentación	FAO
352	Organización de las NN.UU. para la Educación, Ciencia y la Cultura	UNESCO
353	Organización Internacional de Energía Atómica	OIEA
354	Organización Internacional del Trabajo	OIT
355	Organización Mundial de la Salud	OMS
356	Organización Meteorología Mundial	OMM
357	Programa de las NN.UU. para el Desarrollo	PNUD
358	Programa de NN.UU. para el Medio Ambiente	PNUMA
359	Unión Internacional de Telecomunicaciones	UIT
361	Unión Postal Universal	UPU
362	Universidad de las Naciones Unidas	UNU
371	Unión Europea	UE
372	Consejo de Ayuda Mutua Económica	CAME
373	Organización de Países Exportadores de Petróleo	OPEC
374	Programa Mundial de Alimentos	PMA
375	Organización Internacional para las Migraciones	OIM
376	Fondo de NNUU para el Desarrollo de la Capitalización	UNCDF
377	Programa de las NNUU para la Fiscalización Internacional de Drogas	UNDCP
378	Fondo de las NNUU para la Mujer	UNIFEM
379	Fondo Rotativo de las NNUU para la Exploración de los Recursos Naturales	UNRFNRE
384	Fondo Nórdico para el Desarrollo	NDF
386	Organización Internacional de las Maderas Tropicales	OIMT
411	Banco Interamericano de Desarrollo	BID
412	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	BIRF
413	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	FONPLATA
414	Fondo Monetario Internacional	FMI
415	Agencia Internacional de Fomento (BM)	AIF
416	Banco Interamericano de Ahorro y Préstamos	BIAPE
420	Corporación Financiera Internacional (BM)	CFI
421	Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (BM)	MIGA
522	Fondo Multilateral de Inversiones (BID)	FOMIN
524	Fondo para el Medio Ambiente Mundial (BM)	GEF
526	Fondo Institucional de Desarrollo	IDF
730	Banco de Importaciones - Exportaciones China	EXIMBANK-CH
731	Banco de Desarrollo de China	BDC
732	Banco Europeo de Inversiones	BEI
733	Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur	KOICA
734	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	UNODC
735	Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional	OFID
736	Fondo Verde para el Clima	FVC
744	Banco Asiático de Inversión en Infraestructura	AIIB

FUENTE: Clasificadores Presupuestarios 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SIGLA
745	Nuevo Banco de Desarrollo del Brics	NTB BRICS
997	Otros Organismos Financiadores Multilaterales	OT-MUL
	Organismos Bilaterales	**BILAT**
382	Fondo de Ayuda al Equipamiento (España)	FAE
383	Fondo de Integración y Desarrollo Bolivia-Argentina	FIDAB
417	Banco de Importaciones - Exportaciones Japón	EXIMBANK-J
418	Banco de Importaciones - Exportaciones Corea	EXIMBANK-K
419	Banco de Importaciones - Exportaciones (EE. UU.)	EXIMBANK-U
511	Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional	ACDI
512	Agencia de Cooperación Internacional del Japón	JICA
513	Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional	USAID
514	Agencia Danesa de Desarrollo Internacional	DANIDA
515	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación	COSUDE
516	Banco de Crédito para la Reconstrucción	KFW
517	Agencia de Cooperación Técnica de la República Alemana	GIZ
518	Banco de Cooperación Internacional del Japón	JBIC
519	Dir. General de Cooperación Internacional /Coop. Técnica Belga	DGCI -CTB
520	Agencia Sueca de Desarrollo Internacional	ASDI
521	Corporación Internacional de Desarrollo	CID
523	Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional Regional	CIID
525	Instituto de Cooperación Iberoamericana	ICI
527	Agencia Noruega para el Desarrollo Internacional	NORAD
528	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	AECID
529	Corporación de Créditos de Mercaderías (EE. UU.)	CCC
530	Export Development Corporation (CANADA)	EDC
738	Agencia Francesa de Desarrollo	AFD
739	Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo	AICS
740	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	CDP
741	Danske Bank	DKB
742	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres	ONU MUJERES
743	Physikalisch Technische Bundesanstalt	PTB
746	Fondo Saudita para el Desarrollo	SFD
747	Fondo de Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe	KFAED
748	Banco de Exportación e Importación de India	EXIMBANK INDIA
749	Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo	ADFD
998	Otros Organismos Financiadores Bilaterales	OT-BIL
	Gobiernos Extranjeros	**GOB.EXT**
541	República Federal de Alemania	ALEM
542	Argentina	ARG
543	Bélgica	BEL
544	Brasil	BRA
545	Canadá	CANADA
546	República de Corea	COR

FUENTE: Clasificadores Presupuestarios 2024

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SIGLA
548	República Popular China	CHINA
549	República China Nacionalista - Taiwán	CH-TAI
551	Dinamarca	DIN
552	España	ESP
553	Estados Unidos de América	USA
554	Francia	FRA
555	Gran Bretaña	G-BR
556	Holanda	HOL
557	Hungría	HUN
558	Israel	ISR
559	Italia	ITA
561	Japón	JAP
562	Noruega	NOR
563	Perú	PERU
564	Rumania	RUM
565	Suecia	SUE
566	Suiza	SUI
567	Federación de Rusia	RUSIA
568	República Bolivariana de Venezuela	VEN
569	Polonia	POL
571	Austria	AUST
572	Sudáfrica	SUDAF
573	Panamá	PAN
574	Portugal	PORT
575	República de Chile	CHI
576	México	MEX
577	República Oriental del Uruguay	URU
578	Paraguay	PARA
579	Filipinas	FILIP
580	Colombia	COL
581	Ecuador	ECU
582	Cuba	CU
639	Otros Gobiernos Extranjeros	OT-G-EXT
	Otros Organismos Financiadores Externos	**OTR.EXT**
115	Donaciones – HIPC II	DON-HIPC
641	Care	CARE
642	Caritas	CARITAS
643	Plan Internacional	PLAN-INTER
644	Fundación Amigos de la Naturaleza	FAN
669	Otros Organismos no Gubernamentales	OT-NOGUB
671	Bancos Privados	BAN-PRI
672	Proveedores	PROV
719	Organismos Financiadores Externos no Determinados	ND-EXT
720	Basket Funding	BASK-FUN
729	Otros Organismos Financiadores Externos	OT-EXT

FUENTE: Clasificadores Presupuestarios 2024

FAM - BOLIVIA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
MUNICIPALES DE BOLIVIA

unicef
para cada infancia